

Información Paciente

Nombre : Mariana Isidora Carvajal Downey
Edad : 21a 8m 17d
Dirección : Victor Plaza Mayorga 183

Rut : 21.561.424-7
Fecha Nacto: 26/04/2004
Comuna : El Bosque

N° Archivo : 2600178
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 5098 6452

N° Epicrisis
468463

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 04/01/2026 17:36

Días Estadía : 8

Unidad de Egreso : Hosp. Corta Estadía Adulto (Uhcip) 2

Fecha Egreso : 12/01/2026 10:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Intento suicida

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Antecedentes sociodemográficos

paciente, soltera ruptura amorosa hace 1 mes y medio. Dura 1 año y medio la relación. vive con padre Claudio, pareja de padre y hermana. Tiene 5 hermanos. Escolaridad 4to básico completo, actualmente estudiando periodismo finalizado 2do semestre. Hace 3 años inicio psicología, pero congelo y luego abandonó.

Antecedente somáticos

Niega. Fármacos: niega. Cirugía: apendicectomía.

Alergias a fármacos y RAM: relata a los 3 años Steven Johnson, no saben la causa.

Hábitos:

OH: FIC: 15 años. refiere consumo de al menos una vez al mes, ha llegado a la embriaguez. FUC: 1ero de enero, dos vasos de whisky.

THC niega, señala FUC hace >1 año.

Cocaína (-). PBC(-).

BZD ha consumido señala que último consumo habría sido en febrero 2025

Antecedentes psiquiátricos personales:

Múltiples tratamientos con psiquiatras en extrasistema, desde los 15 años, sin tratamiento efectivo. Con diagnóstico de TEPT.

Tratamiento farmacológico previo: ha recibido, quetiapina, escitalopram, sertralina. clotiazepam, clonazepam. No especifica dosis.

Hospitalizaciones: Niega

Suicidalidad: refiere ideas de muerte de larga data, con planificación desde agosto de 2025.

Autoagresiones: con cortes, última 2024.

Eventos adversos durante la adolescencia.

Antecedentes Psiquiátricos familiares:

Madre con diagnóstico de TAB, historia de intento suicida en septiembre del 2025 de familiar. Hermana menor con diagnóstico de TAB y TLP.

Anamnesis próxima:

Motivo de consulta: Intento suicida

Fecha Epicrisis : 12/01/2026 10:48

Paciente con múltiples situaciones familiares durante el 2025 (madre intento suicida mediante ingesta farmacológica en septiembre 2025, hermana dos intentos suicidas en el 2025), sumado a quiebre de relación de pareja hace 1 mes y medio, el cual relata fue repentino e inesperado, lo cual gatilla ideación suicida con planificación. Paciente relata tener ideas de muerte de larga data, en agosto del 2025 escribe cartas de despedida, pero luego se arrepiente y las borra. Debido a todos los hechos acontecidos, relata que planifica en intento al menos 2 días antes de realizarlo para año nuevo, dado que era un momento "adecuado porque estarían todos carreteando"; señala haber dejado múltiples cartas de despedidas, haber investigado sobre método de letalidad, haber tomado en consideración temporalidad de efecto adverso de paracetamol, sin embargo ante dolor intenso solicita ayuda a su psicoterapeuta, debido a dicha situación es llevada al servicio de urgencias.

Paciente ingresa al SU HLF el 01/01/26 por la ingesta voluntaria de 80 cp de paracetamol de 500 mg asociado a OH. Ingres a estable, bien perfundida y Glasgow 15. Refiere solo dolor abdominal y náuseas. Durante las sgtes 48 hr evoluciona más somnolienta, con mayor dolor abdominal y con ez hepáticas + INR al alza. Se inicia NAC desde un inicio. NP PCT 12,5 (01/01 19:47 hr). Dada la mala evolución clínica y de laboratorio se decide traslado a centro con resolución por posible trasplante hepático. Ingres a UPC HSR en buenas condiciones generales, Hemodinmicamente estable, Glasgow 15, con leve ictericia en escleras, sin flapping y leve dolor abdominal. Se logra estabilizar del daño hepatico agudo y se solicita evaluación por psiquiatria de enlace por ideas suicidas y cierto oposicionismo, posterior a evaluación, se describe en evolución por dicho equipo paciente sin ideación suicida activa en último control. Se decide su ingreso a UHCIP-2.

Examen mental de Ingreso:

Vigil, orientada en tiempo y espacio, atenta. Aspecto: apariencia física acorde a edad cronológica, peinada, vestida con pijama, con acné en cara, arreglo simple. Actitud: colaboradora y a ratos y poco facilitada. Contacto: sintónico. Psicomotricidad: mímica facial conservada, movimientos accesorios ligeramente aumentados (pasa toda la entrevista moviendo las manos y tocándose la cara). Afecto amplio, a ratos discordante, parcialmente modulado y con momentos de labilidad emocional. Lenguaje: velocidad conservada, intención notificativa, sin alteraciones en prosodia, ni morfosintaxis. Pensamiento: velocidad conservada, sin alteraciones en la estructura, sin ideas delirantes, sin alteraciones en la experiencia ni control del pensamiento. Sin Ideación suicida. Sin alteraciones en la sensopercepción durante la entrevista. Insight: escaso. Juicio: no psicótico

Hipótesis diagnósticas de Ingreso:

Eje I:

Intento suicida reciente de alta letalidad, sin ideación suicida actual.

Trastorno anímico en evaluación.

Eje II:

Elementos caracterológicos cluster B.

Eje III:

Insuficiencia hepática aguda tratada.

Eje IV:

Red de apoyo presenten, Eventos adversos en la adolescencia, VIF.

Evolución durante hospitalización

Paciente quien ingresa el 9/01/26 de forma voluntaria desde UPC, con signos vitales estables y ritmos biológicos conservados. En entrevista de ingreso se evidencia paciente un poco facilitada, con afecto amplio, discordante y a ratos disociado. Con múltiples quejas relacionadas a conflictos interpersonales con familiares y ex-pareja, además de eventos adversos vivido durante la adolescencia. En entrevista con la madre relata que la paciente es -"muy explosiva", con emociones muy intensas. Relata que recibió 2 tratamientos farmacológicos en el pasado, pero ambos los abandonó.

Paciente quién 48 horas posterior a su ingreso, (durante fin de semana) solicita alta contraindicación médica, aduce no está cómoda con el proceso hospitalario y que quiere que familiares la cuiden. Sin ideación suicida activa desde su ingreso. Paciente en condiciones para decidir respecto de su hospitalización, no se cumplen criterios clínicos para cursar hospitalización involuntaria de acuerdo a normativa vigente.

(paciente evaluada por becada y supervisada por staff psiquiatra Dr. Licanqueo quienes estaban de turno al momento de la solicitud de alta de paciente)

Se da aviso a tutora de hospitalización y se firma alta contraindicación médica.

Desde el punto de vista somático, no presenta complicaciones durante su hospitalización. Se solicitan exámenes de lab de

Fecha Última Actualización: 12-01-2026 10:48:21

Página 3 de 4

ingreso, pero debido a que paciente solicita alta contraindicación médica, no se logran tomar.

*última evaluación por equipo de medicina interna previo a traslado a UHCIP: " Insuficiencia hepática aguda en contexto de sobredosis de PCT, ingresa con alza de transaminasas, INR y bilirrubina. Se administró NAC en HLF, se continúa al ingreso en HSR con evaluación de pruebas hepáticas cada 6 hrs. Evolucionó con disminución de valores en pruebas hepáticas, disminución de dolor abdominal y sin compromiso neurológico. Se finaliza esquema de NAC el 06/01. Evaluado por equipo de trasplante, quienes desestiman indicación de trasplante hepático".

Examen mental de egreso:

Vigil, orientada temporoespacialmente, atenta clínicamente. Apariencia física acorde a edad cronológica, despeinada, vestida acorde. Ectomorfa. Actitud: Cooperadora. Contacto sintónico. Psicomotricidad global conservada con mímica y gestualidad accesoria conservada. Ánimo refiere eutímico. Afecto amplio, modulado, algo disociado, concordante. Lenguaje velocidad, articulación y prosodia conservada. Notificativa. Pensamiento velocidad conservada, sin alteraciones formales. Contenido centrado en solicitud de alta médica. Sin ideas delirantes espontáneas. Sin ideación suicida activa. Sin alteraciones sensorio-perceptivas. Juicio no psicótico. Insight bajo.

Exámenes:

Laboratorio: 09/01/26: Albumina 3.5, BT 0.59, BD 0.28, FA 83, GGT 72, GOT 66, GPT 1177, creatinina 0.88, BUN 11.8, LDH 182, PCR 9.0, NA 139, K 3.80, CL 108, HTo 35.3, HB 11.7, Leucocitos 4.88, Plaquetas 183, Hepatitis B y C no reactivo, Chagas y HTLV/HTLV II no reactivo, VDRL no reactivo.

TC de abdomen y pelvis 03/01/26: Antecedentes clínicos: Falla hepática aguda. Impresión: Leve ascitis. Resto del estudio sin hallazgos de significado patológico que consignar.

TC de cerebro sin contraste 03/01/26: Antecedentes clínicos: Falla hepática aguda. Sospecha de edema cerebral. TC de cerebro no c o n trastada sin hallazgos de significado patológico que consignar.

Diagnósticos de egreso:

Eje I:

Intento suicida reciente de alta letalidad, sin ideación suicida actual.

Trastorno anímico a evaluar.

Eje II:

Elementos caracterológicos cluster B.

Eje III:

Insuficiencia hepática aguda tratada.

Eje IV:

Red de apoyo presente, Eventos adversos en la adolescencia, VIF.

Diagnóstico de Egreso

OTROS TRASTORNOS DEL HUMOR [AFECTIVOS] - Intento suicida reciente de alta letalidad, sin ideación suicida actual.
Trastorno anímico a evaluar.

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente egresa sin conflictos médicos. Estable desde lo conductual. Sin ideación suicida, ni ideas de heteroagresión, sin ideas delirantes.

Plan Post Alta

Indicaciones al alta:

1. Alta contraindicación médica. Se firma alta contraindicación médica. Se deriva a COSAM CEIF para seguimiento.
2. Sin necesidad de reposo, durante la primera semana desde el alta hospitalaria se sugiere mantenerse acompañado. Fármacos deben ser administrados por familiar.
3. Cuidados domiciliarios y recomendaciones generales:
Hábitos de higiene del sueño: mantener rutina con horarios para dormir, evitar uso de pantallas cercano a dormir y evitar cafeína luego de las 18 horas (bebidas energéticas, café, té, bebidas cola, mate).
Abstinencia de uso de sustancias (incluyendo alcohol).

Fecha Epicrisis : 12/01/2026 10:48

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 12-01-2026 10:48:21

Página 4 de 4

Alimentación: Evitar alimentos procesados (comida chatarra), favorecer el consumo de frutas, verduras y fibras (Dieta mediterránea).

Realizar actividad física regular a tolerancia de manera inicial para lograr una frecuencia de 30 minutos 5 veces por semana (En total 150 a 300 min semanales). La intensidad del ejercicio debe ser de moderada a alta intensidad (Ej: al realizar ejercicio usted debe ser capaz de decir algunas pocas palabras con algo de esfuerzo).

Organización del espacio físico y retiro o resguardo de elementos de riesgo (tóxicos, cortopunzantes)

Asistencia a los primeros controles médicos acompañado.

5. Terapia farmacológica:

Lorazepam 2mg: 0-0-1/2 vo

Omeprazol 20mg 1-0-0 vo

6. Se deriva a CESFAM para seguimiento con pruebas hepáticas por I. Hepática resuelta. Último laboratorio (09/01) enzimas a la baja. Sin control posterior por alta contraindicación médica, sin conflictos según lo escrito por medicina en última evolución.

7. En caso de aparición de ideación suicida, ideas de heteroagresión o sintomatología psicótica, acudir a Servicio de Urgencias.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Levantar Diariamente

Régimen Alimentario : Común

Medicamentos : Omeprazol 20mg 1-0-0 Vo
Lorazepam 2 Mg 0-01/2 Vo

Controles

INTERNO



Bec. Cilisneth Vargas Galue
Becado/Residente



Valentina Valderrama Ávila
Médico Tratante (Staff)